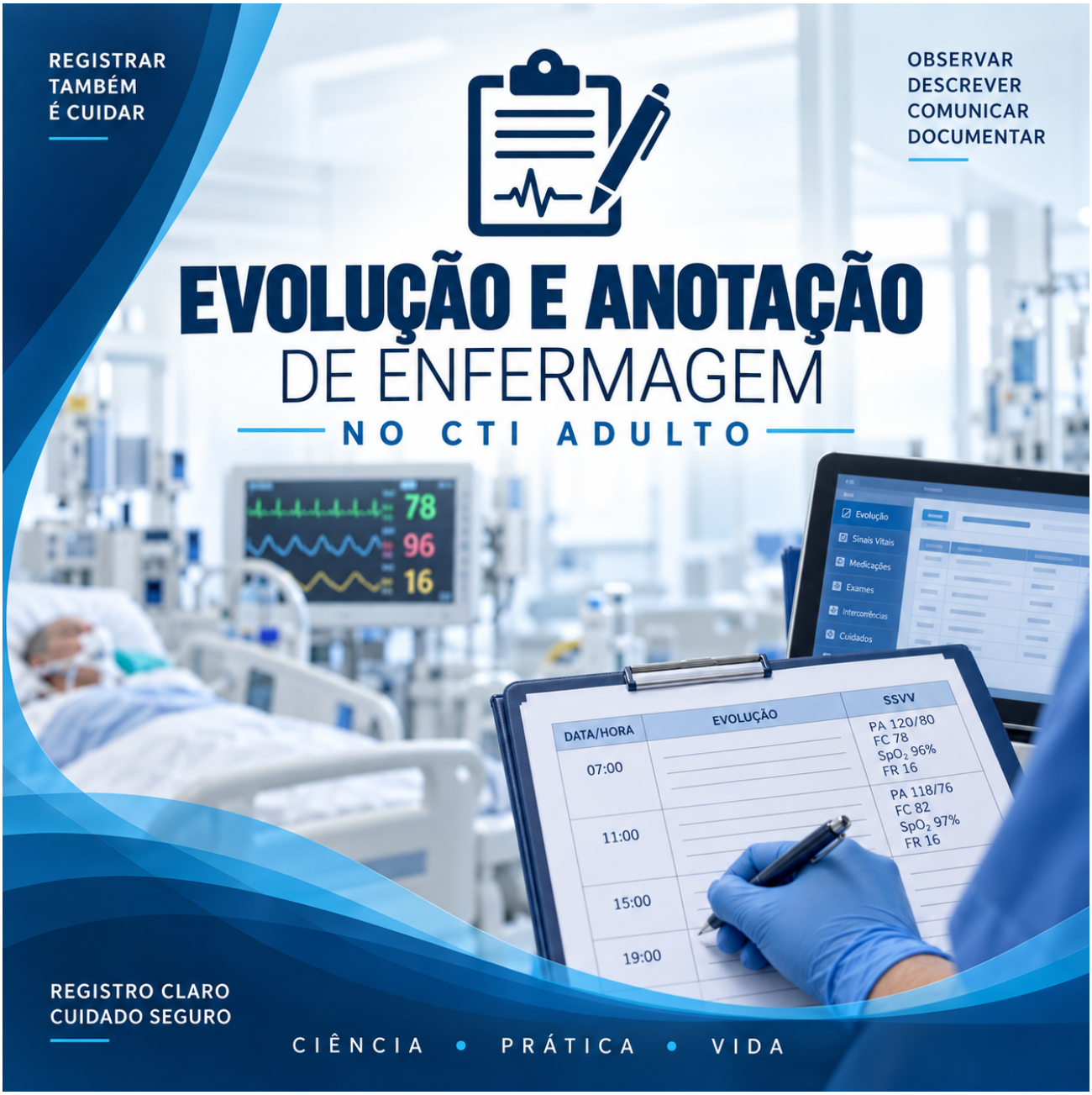

APOSTILA EM FICHAS • ENFERMAGEM NO CTI ADULTO

Registros seguros, anotações do técnico, evolução do enfermeiro, exemplos práticos e padrão institucional.

Setembro de 2026 • Material educativo • Referências oficiais ao final

Como usar esta apostila

Este material foi construído para estudo e consulta rápida no CTI adulto. Ele integra o conteúdo dos slides da Profª Enfª Bruna Martelli com as normas profissionais vigentes e com exemplos de situações críticas.

Ideia central

Observar → cuidar → avaliar a resposta → comunicar → registrar. O prontuário precisa mostrar, em ordem cronológica, o que aconteceu com o paciente, o que foi feito e qual foi a resposta.

Limite profissional

A evolução de enfermagem, como etapa do Processo de Enfermagem, é atribuição privativa do enfermeiro. O técnico participa executando cuidados, checando a prescrição, observando respostas, comunicando alterações e realizando anotações de enfermagem sob supervisão.

Objetivos de aprendizagem

- Diferenciar anotação, evolução, checagem e comunicação.
- Produzir registros objetivos, cronológicos, completos e rastreáveis.
- Aplicar o padrão Recebo, Refere, Apresenta, Mantém e Realizado.
- Registrar medicamentos, dispositivos, feridas, eliminações e intercorrências.
- Reconhecer registros inadequados e corrigi-los de forma segura.
- Proteger sigilo, privacidade e dados do paciente.

1. Registro de enfermagem: por que ele importa

O registro é parte do cuidado. Ele orienta decisões, sustenta a continuidade assistencial e demonstra o trabalho realizado.

Continuidade do cuidado

O QUE SIGNIFICA

O prontuário conecta turnos e profissionais.

NA PRÁTICA

Registre informações que mudam conduta: condição atual, dispositivos, terapias, riscos, respostas e pendências.

ATENÇÃO

Uma anotação incompleta pode produzir repetição, atraso ou omissão de cuidado.

Segurança e qualidade

O QUE SIGNIFICA

Dados confiáveis permitem reconhecer tendências e avaliar resultados.

NA PRÁTICA

Anote valores exatos, horários e resposta do paciente. Compare com registros anteriores e comunique piora.

ATENÇÃO

“Paciente bem” ou “estável” não substitui dados observáveis.

Valor ético e legal

O QUE SIGNIFICA

O registro identifica quem realizou o cuidado e quando ele ocorreu.

NA PRÁTICA

Use autenticação profissional individual; nunca registre por outra pessoa nem compartilhe senha.

ATENÇÃO

Registro não realizado ou feito de modo inconsistente fragiliza a assistência e a rastreabilidade.

Ensino, pesquisa e auditoria

O QUE SIGNIFICA

Registros qualificados permitem avaliar processos e melhorar a assistência.

NA PRÁTICA

Escreva para que outro profissional compreenda sem precisar adivinhar.

ATENÇÃO

O prontuário pertence à assistência e deve respeitar finalidade, sigilo e acesso autorizado.

2. Anotação, evolução, checagem e comunicação

Os quatro elementos se complementam, mas não são sinônimos.

Anotação de enfermagem

O QUE SIGNIFICA

Registro pontual, cronológico e objetivo de dados observados, cuidados realizados e respostas.

NA PRÁTICA

Pode ser realizada por profissionais de enfermagem dentro de suas atribuições e deve conter data, hora e identificação/autenticação.

ATENÇÃO

O técnico não transforma a anotação em diagnóstico ou prescrição.

Evolução de enfermagem

O QUE SIGNIFICA

Avaliação clínica deliberada do enfermeiro sobre respostas do paciente ao longo do período, vinculada ao Processo de Enfermagem.

NA PRÁTICA

O enfermeiro interpreta os dados, avalia resultados e subsidia revisão do plano de cuidados.

ATENÇÃO

É atividade privativa do enfermeiro conforme a Resolução Cofen nº 736/2024.

Checagem

O QUE SIGNIFICA

Confirmação de que uma ação prescrita foi efetivamente realizada.

NA PRÁTICA

Cheque somente após executar e registre justificativa/conduta quando não for possível realizar, conforme o sistema institucional.

ATENÇÃO

Nunca cheque antecipadamente ou por outro profissional.

Comunicação

O QUE SIGNIFICA

Transmissão imediata de informação relevante para a pessoa certa.

NA PRÁTICA

Diante de alteração, comunique antes de “terminar a anotação”; depois registre o achado, quem foi avisado, horário e conduta.

ATENÇÃO

Registrar não substitui chamar ajuda em uma urgência.

Comparação rápida

Use este quadro para escolher o tipo correto de registro e não ultrapassar o limite profissional.

Elemento	Função principal
Anotação	Fato pontual: observação, cuidado e resposta, em ordem cronológica.
Evolução	Avaliação clínica do enfermeiro sobre respostas e resultados do plano.
Checagem	Confirma execução da ação prescrita.
Comunicação	Faz a informação crítica chegar imediatamente à pessoa certa.

Responsável	Registro esperado
Técnico de enfermagem	Anota dados observados e relatados, cuidados realizados, checagem, intercorrências, respostas e comunicações, sob supervisão.
Enfermeiro	Registra também suas anotações e realiza a evolução, o diagnóstico e a prescrição de enfermagem no Processo de Enfermagem.
Equipe multiprofissional	Cada profissão registra sua avaliação e conduta dentro das próprias atribuições.
Regra de segurança	Ninguém registra, assina ou autentica por outro profissional.

Na dúvida

Descreva o fato observado, comunique o enfermeiro e peça orientação. Não transforme uma observação em diagnóstico nem omita informação por receio de registrar.

3. Características de um registro de qualidade

A anotação deve reproduzir os fatos de modo fiel, compreensível e útil.

Clareza e objetividade

O QUE SIGNIFICA

Frases diretas, sem julgamento ou ambiguidade.

NA PRÁTICA

Prefira “recusa banho, refere frio” a “paciente difícil e não colaborativo”.

ATENÇÃO

Evite rótulos como “queixoso”, “agitado demais” ou “mal-educado”.

Cronologia e oportunidade

O QUE SIGNIFICA

Os fatos devem aparecer na ordem em que ocorreram.

NA PRÁTICA

Registre logo após o cuidado ou observação. Se houver registro tardio, identifique-o conforme a política institucional.

ATENÇÃO

Não altere horário para simular registro contemporâneo.

Precisão

O QUE SIGNIFICA

Dados mensuráveis descrevem melhor a situação.

NA PRÁTICA

Use valor, unidade, local, aspecto, quantidade, intensidade e horário: PA 86/52 mmHg; diurese 20 mL; dor 7/10.

ATENÇÃO

Não use “normotenso”, “afebril” ou “diurese boa” quando o valor pode ser registrado.

Completude com concisão

O QUE SIGNIFICA

Inclua o necessário sem copiar textos genéricos.

NA PRÁTICA

Diga o que observou, o que fez, como o paciente respondeu e quem foi comunicado.

ATENÇÃO

Copiar anotações anteriores pode perpetuar erros e ocultar mudança clínica.

Linguagem padronizada

O QUE SIGNIFICA

Termos e siglas devem ser compreendidos pela equipe.

NA PRÁTICA

Use somente abreviações autorizadas pela instituição e escreva nomes de modo inequívoco.

ATENÇÃO

Abreviações ambíguas aumentam risco, sobretudo em medicações.

4. O que o técnico de enfermagem deve registrar no CTI

O conteúdo varia conforme o paciente, a prescrição e o protocolo, mas alguns grupos de informação são recorrentes.

Condição observável

O QUE SIGNIFICA

Consciência, comunicação, respiração, perfusão, dor, mobilidade, pele e comportamento.

NA PRÁTICA

Registre achados e valores dentro de sua avaliação/competência, sem formular diagnóstico de enfermagem.

ATENÇÃO

Mudança súbita exige escalonamento imediato.

Cuidados realizados

O QUE SIGNIFICA

Higiene, posicionamento, mobilização, prevenção, aspiração, curativos e demais ações executadas.

NA PRÁTICA

Inclua horário, técnica relevante, tolerância e resposta.

ATENÇÃO

Não registre como feito o que ficou pendente.

Terapias e dispositivos

O QUE SIGNIFICA

Oxigênio, ventilação, acessos, sondas, cateteres, drenos, dietas e bombas.

NA PRÁTICA

Informe local, condição, fixação, débito/aspecto quando aplicável e alterações comunicadas.

ATENÇÃO

Evite afirmar posicionamento interno sem confirmação diagnóstica.

Medicamentos

O QUE SIGNIFICA

Administração, horário, via, acesso, intercorrências e resposta quando clinicamente necessária.

NA PRÁTICA

Faça a checagem e registre dados adicionais exigidos: glicemia, pressão, dor, reação, infusão ou motivo de não administração.

ATENÇÃO

O prontuário não deve ocultar atraso, omissão ou reação adversa.

Eliminações e balanço

O QUE SIGNIFICA

Diurese, evacuação, vômitos, drenos e outras perdas.

NA PRÁTICA

Quantifique quando possível e descreva aspecto relevante. Atualize o balanço nos horários definidos.

ATENÇÃO

Débito reduzido ou mudança abrupta deve ser comunicada.

Comunicações e eventos

O QUE SIGNIFICA

Alterações, recusas, incidentes, condutas e profissionais avisados.

NA PRÁTICA

Registre fato, horário, avaliação, ação, resposta e comunicação, sem acusação ou julgamento.

ATENÇÃO

Relatório de incidente não substitui o registro assistencial no prontuário.

Mapa visual • Processo de Enfermagem no paciente crítico

Fonte visual: 350 mapas mentais UTI atualizado, página 25 do PDF enviado pelo usuário.

Leitura crítica: O técnico participa da implementação, checagem, anotação e comunicação. Diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem são atribuições do enfermeiro.

5. Avaliação organizada da cabeça aos pés

O método cefalocaudal ajuda a não esquecer informações importantes, mas deve ser adaptado à gravidade e à prioridade clínica.

Neurológico e comunicação

O QUE SIGNIFICA

Nível de consciência, orientação, fala, resposta, pupilas quando indicado, sedação e dor.

NA PRÁTICA

Ex.: “sonolento, desperta ao chamado, responde com frases curtas; refere cefaleia 6/10”.

ATENÇÃO

Use escalas apenas quando treinado, autorizado e conforme protocolo.

Respiratório

O QUE SIGNIFICA

Padrão respiratório, suporte de O_2, SpO_2, secreção, tosse e tolerância.

NA PRÁTICA

Ex.: “em cateter nasal 2 L/min, SpO_2 95%, FR 20 irpm, sem uso de musculatura acessória”.

ATENÇÃO

Dessaturação ou desconforto requer avaliação e comunicação imediatas.

Cardiovascular e perfusão

O QUE SIGNIFICA

PA, FC, ritmo exibido, perfusão, temperatura de extremidades, edema e sangramento.

NA PRÁTICA

Correlacione valores do monitor com condição clínica e confirme medidas incoerentes.

ATENÇÃO

O técnico descreve o dado; interpretação diagnóstica cabe ao profissional competente.

Gastrointestinal e nutrição

O QUE SIGNIFICA

Dieta, tolerância, abdome observado, náusea, vômito e evacuação.

NA PRÁTICA

Registre via, volume administrado quando exigido, pausa, motivo e resposta.

ATENÇÃO

Distensão, vômito ou risco de aspiração devem ser comunicados.

Geniturinário

O QUE SIGNIFICA

Via de eliminação, volume e aspecto da urina, integridade do sistema coletor.

NA PRÁTICA

Ex.: “SVD em sistema fechado; 40 mL de urina amarelo-escura no período”.

ATENÇÃO

Anúria, sangue, obstrução ou desconexão exige ação imediata.

Pele, mobilidade e dispositivos

O QUE SIGNIFICA

Integridade, lesões, risco de pressão, posicionamento, acessos, drenos e fixações.

NA PRÁTICA

Descreva local, medida, aspecto e cuidado; registre mudança de decúbito e tolerância.

ATENÇÃO

Evite termos genéricos como “pele íntegra” sem inspeção adequada.

Mapa visual • SAE na UTI

Fonte visual: 350 mapas mentais UTI atualizado, página 26 do PDF enviado pelo usuário.

Leitura crítica: Use o mapa como revisão da organização do cuidado. As atribuições devem ser interpretadas conforme a Resolução Cofen nº 736/2024 e os protocolos da instituição.

6. Registros em situações de alto risco

No CTI, a anotação precisa tornar visíveis alterações, respostas e decisões tomadas em tempo oportuno.

Deterioração clínica

O QUE SIGNIFICA

Mudança respiratória, circulatória ou neurológica deve ser registrada com dados objetivos.

NA PRÁTICA

Inclua horário, achados, valores, ações iniciais, profissionais acionados, condutas e resposta.

ATENÇÃO

Atenda e comunique primeiro; registre assim que a situação estiver segura.

Queda ou outro incidente

O QUE SIGNIFICA

Descreva os fatos sem procurar culpados.

NA PRÁTICA

Registre como e quando foi encontrado, avaliação, lesões/queixas, sinais vitais, profissionais comunicados e medidas adotadas.

ATENÇÃO

Não escreva “sem dano” sem avaliação; siga também o sistema institucional de notificação.

Recusa

O QUE SIGNIFICA

O paciente pode recusar um cuidado, mas precisa receber informação e avaliação adequadas.

NA PRÁTICA

Registre o cuidado oferecido, motivo referido entre aspas quando relevante, orientação, comunicação e nova abordagem.

ATENÇÃO

Não use termos punitivos nem abandone o cuidado.

Reação a medicamento

O QUE SIGNIFICA

Sinais e sintomas após administração exigem correlação temporal e resposta rápida.

NA PRÁTICA

Registre medicamento, dose/rota/horário, achados, sinais vitais, interrupção quando indicada, comunicação, conduta e resposta.

ATENÇÃO

Não conclua “alergia” sem avaliação; descreva os achados.

Parada cardiorrespiratória

O QUE SIGNIFICA

A documentação deve reconstruir a sequência do evento e intervenções.

NA PRÁTICA

Registre horário do reconhecimento/acionamento, condições encontradas, RCP, ritmo/choques/medicações segundo folha própria, profissionais e desfecho.

ATENÇÃO

Use o formulário institucional e evite estimar horários quando há fonte confiável.

Óbito e cuidados pós-óbito

O QUE SIGNIFICA

Exigem respeito, identificação e cumprimento de fluxo legal e institucional.

NA PRÁTICA

Registre constatação pelo profissional habilitado, horário informado, cuidados realizados, identificação, pertences e destino conforme protocolo.

ATENÇÃO

O técnico não declara óbito.

7. Papel, prontuário eletrônico e correções

A forma muda, mas autenticidade, integridade, confidencialidade e rastreabilidade permanecem obrigatórias.

Registro em papel

O QUE SIGNIFICA

Deve permanecer legível e sem espaços que permitam acréscimos indevidos.

NA PRÁTICA

Use caneta e identificação conforme a instituição. Em erro, siga a técnica institucional de correção preservando a leitura e a autoria.

ATENÇÃO

Nunca use corretivo, raspe, apague ou encubra o conteúdo.

Registro eletrônico

O QUE SIGNIFICA

A autenticação vincula a informação ao usuário que a inseriu.

NA PRÁTICA

Use somente seu acesso, confira paciente e tela antes de salvar e siga o mecanismo de adendo/correção do sistema.

ATENÇÃO

Senha compartilhada elimina rastreabilidade e viola segurança.

Registro tardio

O QUE SIGNIFICA

Quando o cuidado não pôde ser documentado no momento, a entrada precisa deixar isso transparente.

NA PRÁTICA

Use “registro tardio” ou recurso equivalente, informando hora real do fato e motivo, conforme política institucional.

ATENÇÃO

Nunca altere retroativamente o horário para esconder atraso.

Cópia e preenchimento automático

O QUE SIGNIFICA

Ferramentas digitais podem acelerar o registro, mas aumentam o risco de informação desatualizada.

NA PRÁTICA

Revise cada campo, remova dados não aplicáveis e valide se o texto corresponde ao paciente naquele momento.

ATENÇÃO

Não copie evolução ou anotação de outro turno sem reavaliar.

8. Sigilo, privacidade e LGPD

Dados de saúde são sensíveis e devem ser acessados apenas para finalidades legítimas da assistência.

Acesso mínimo necessário

O QUE SIGNIFICA

Consultar somente prontuários relacionados ao trabalho autorizado.

NA PRÁTICA

Feche a tela ao se afastar, proteja impressos e descarte documentos conforme protocolo.

ATENÇÃO

Curiosidade não é justificativa para acessar prontuário.

Conversas e mensagens

O QUE SIGNIFICA

Informação clínica não deve circular em espaços ou canais não autorizados.

NA PRÁTICA

Converse em local adequado e use somente ferramentas institucionais aprovadas.

ATENÇÃO

Não fotografe tela, paciente ou prontuário com aparelho pessoal.

Respeito e dignidade

O QUE SIGNIFICA

A linguagem do prontuário deve ser técnica e não discriminatória.

NA PRÁTICA

Registre fatos, falas relevantes e comportamento observável, preservando contexto e dignidade.

ATENÇÃO

Comentários depreciativos ou julgamentos não pertencem ao prontuário.

Compartilhamento com família

O QUE SIGNIFICA

A equipe deve seguir autorização, vínculo e fluxo institucional.

NA PRÁTICA

Encaminhe solicitações clínicas ao profissional responsável e preserve informações diante de terceiros.

ATENÇÃO

Não forneça diagnóstico ou prognóstico fora de sua atribuição.

9. Padrão institucional para registros e anotações de enfermagem

Este capítulo integra o material da Profª Enfª Bruna Martelli. O roteiro foi reorganizado para consulta prática e atualizado para contemplar registros em papel e eletrônicos.

Sequência para admissão

RECEBO → REFERE → APRESENTA → MANTÉM → REALIZADO.

Sequência para rotina

REFERE → APRESENTA → MANTÉM → REALIZADO.

RECEBO

O QUE SIGNIFICA

Situa o início da assistência: origem, meio de transporte, acompanhante/equipe e condições iniciais relevantes.

NA PRÁTICA

“Recebo paciente proveniente do pronto atendimento, em maca, acompanhado pela equipe, monitorizado e em O_2 por máscara.”

ATENÇÃO

Confirme identidade, alergias, terapias em curso e dispositivos no momento da transferência.

REFERE

O QUE SIGNIFICA

Registra informação subjetiva relatada pelo paciente.

NA PRÁTICA

Use linguagem fiel e, quando necessário, coloque a fala entre aspas: “refere ‘aperto no peito’ há cerca de 20 minutos”.

ATENÇÃO

Se o paciente não puder informar, registre a limitação e a fonte da informação.

APRESENTA

O QUE SIGNIFICA

Descreve o que é observado ou medido, preferencialmente em sequência cefalocaudal.

NA PRÁTICA

Consciência, respiração, circulação, dor, abdome, pele, mobilidade e outros achados, com valores exatos.

ATENÇÃO

Evite inferências diagnósticas e adjetivos vagos.

MANTÉM

O QUE SIGNIFICA

Lista suportes e dispositivos presentes, com local, condição e dados relevantes.

NA PRÁTICA

Ex.: “mantém CVC em jugular direita, curativo limpo e seco, sem hiperemia ou secreção observável”.

ATENÇÃO

Inclua data de inserção apenas quando confirmada no prontuário ou identificação do dispositivo.

REALIZADO

O QUE SIGNIFICA

Registra cuidados e medicamentos executados, incluindo resposta.

NA PRÁTICA

Ex.: “realizada mudança para decúbito lateral esquerdo, coxins posicionados; paciente tolerou sem dessaturação”.

ATENÇÃO

Não omita intercorrência, pendência ou motivo de não realização.

Regra prática do material institucional

Anotar pelo menos uma vez por turno e sempre que necessário, seguindo o fluxo do serviço. A frequência mínima institucional não limita o dever de registrar alterações, cuidados e respostas relevantes imediatamente.

10. Exemplos práticos de anotações no CTI

Os modelos abaixo mostram estrutura e nível de detalhe. Devem ser adaptados ao paciente, ao sistema e ao protocolo local; nunca devem ser copiados sem avaliação.

Admissão

Exemplo

14:20 - Recebo paciente proveniente do centro cirúrgico, em maca, acompanhado por anestesista e equipe de enfermagem, monitorizado. Sonolento, desperta ao chamado, obedece a comandos simples. Em máscara de O_2 a 5 L/min, SpO_2 96%, FR 18 irpm; PA 112/68 mmHg, FC 88 bpm. Mantém acesso venoso periférico em MSD, sem edema ou hiperemia, e SVD em sistema fechado, com 120 mL de urina amarelo-clara. Pele sacral íntegra à inspeção. Realizada transferência para o leito com equipe, instalação de monitor e medidas de segurança. Enfermeira responsável presente na admissão. [identificação profissional]

Rotina do turno

Exemplo

08:10 - Refere dor em região abdominal, intensidade 6/10. Alerta e orientado, em ar ambiente, SpO_2 97%, FR 19 irpm. Abdome distendido; mantém dreno em flanco direito, fixo, com 30 mL de conteúdo sero-hemático desde 06:00. Realizado posicionamento e administrado analgésico conforme prescrição. Enfermeira comunicada às 08:15. Às 08:50, paciente refere dor 2/10, sem náusea. [identificação profissional]

Medicação e resposta

Exemplo

10:00 - Glicemia capilar 248 mg/dL. Administrada insulina regular conforme prescrição, por via subcutânea em abdome, após conferências. Paciente orientado quanto ao procedimento. Sem intercorrências imediatas. Enfermeira ciente do valor. [identificação profissional]

Mudança clínica

Exemplo

16:42 - Paciente apresenta dispneia súbita, uso de musculatura acessória, SpO_2 84% em cateter nasal 2 L/min, FR 32 irpm, FC 118 bpm. Cabeceira elevada e enfermeira/equipe médica acionadas imediatamente. Suporte de O_2 ajustado pela equipe conforme prescrição, com SpO_2 93% às 16:48. Permanece monitorizado. [identificação profissional]

Recusa

Exemplo

18:30 - Oferecida higiene oral. Paciente recusa e refere “minha boca está dolorida”. Observada área avermelhada em mucosa jugal direita, sem sangramento. Enfermeira comunicada às 18:34; cuidado adiado para avaliação e nova abordagem. [identificação profissional]

11. Antes e depois: como tornar o registro útil

Evite	Prefira
“Paciente bem.”	Melhor: alerta, orientado, sem queixas no momento; PA 118/74 mmHg, FC 76 bpm, SpO_2 97% em ar ambiente.
“Diurese boa.”	Melhor: diurese de 350 mL no período, amarelo-clara, por SVD em sistema fechado.
“Acesso normal.”	Melhor: AVP em antebraço esquerdo, curativo limpo e seco, sem edema, hiperemia ou dor referida.
“Paciente agitado.”	Melhor: tenta retirar cateter nasal e levantar do leito, fala em tom elevado; desorientado quanto ao local.
“Feito curativo.”	Melhor: realizado curativo em região sacral conforme prescrição; lesão 2 x 1 cm, leito avermelhado, pequena quantidade de exsudato seroso; cobertura aplicada.
“Médico ciente.”	Melhor: Dr(a). [nome] comunicado(a) às 14:12 sobre PA 82/48 mmHg; avaliação realizada às 14:16 e conduta registrada.
“Não quis medicação.”	Melhor: paciente recusa medicação e refere “me deixa enjoado”; orientado, enfermeira comunicada e dose não administrada conforme conduta.
“Sem alterações.”	Melhor: descreva os sistemas e dispositivos relevantes; “sem alterações” isolado não mostra o que foi avaliado.

Fórmula de uma boa anotação

Horário + dado observado/relatado + cuidado/intervenção + resposta + comunicação + identificação.

12. Checklist antes de finalizar o registro

☐ Estou no prontuário do paciente correto?

☐ A data e o horário correspondem ao momento real?

☐ Diferenciei o que o paciente referiu do que observei?

☐ Usei valores, unidades, local e aspecto quando possível?

☐ Registrei o cuidado realizado e a resposta?

☐ Identifiquei alterações, pendências, recusas ou motivo de não realização?

☐ Registrei quem foi comunicado e em que horário?

☐ Evitei julgamento, rótulo e abreviação não padronizada?

☐ Revisei erros de paciente, medicamento, via, dispositivo e lateralidade?

☐ Assinei/autentiquei com minha própria identificação profissional?

Pergunta final

Outro profissional, lendo apenas esta anotação, consegue compreender o que aconteceu, o que foi feito e como o paciente respondeu?

Exercícios de fixação

1. Reescreva

“Paciente confuso, muito ruim, médico avisado.” Inclua comportamento observável, valores, horário, ação e comunicação.

2. Diferencie

Marque quais itens pertencem à anotação do técnico e quais exigem evolução/decisão do enfermeiro.

3. Organize

Coloque em ordem: Realizado, Recebo, Mantém, Refere, Apresenta.

4. Analise

Uma medicação foi checada, mas não administrada. Quais riscos existem e como corrigir o fluxo?

5. Simule

Crie uma anotação de paciente ventilado com mudança de SpO_2, aspiração, comunicação e resposta.

Gabarito orientador

1. Deve conter achados concretos (por exemplo, desorientação, tentativa de sair do leito, Glasgow se aplicável), sinais vitais, horário, medidas de segurança, profissional comunicado e resposta.

2. O técnico registra observações, cuidados, checagem e respostas. A evolução clínica no Processo de Enfermagem, diagnóstico e prescrição são do enfermeiro.

3. Admissão: Recebo → Refere → Apresenta → Mantém → Realizado.

4. A checagem incorreta compromete a segurança. Comunicar imediatamente, seguir correção institucional, registrar o fato e nunca ocultar o erro.

5. Deve reconstruir a sequência: condição inicial, valores, sinais observados, cuidado realizado dentro da competência, profissionais acionados e resposta.

Mapa-resumo do registro seguro

Etapa	Pergunta-chave
1. Identifique	Paciente, data, hora e autoria.
2. Observe	Dados subjetivos e objetivos, separados.
3. Faça	Cuidado, medicação ou medida de segurança.
4. Reavalie	Resposta e tendência.
5. Comunique	Alteração, profissional e horário.
6. Registre	Cronologia, precisão e sigilo.

Referências e materiais integrados

Consultadas em 23/09/2026. A prática deve seguir as normas vigentes e o protocolo institucional.

Material da professora integrado: MARTELLI, Bruna. Anotação de Enfermagem. Material de aula fornecido pelo usuário. Conteúdo reorganizado no capítulo “Padrão institucional para registros e anotações de enfermagem”.

Material visual fornecido pelo usuário: 350 mapas mentais UTI atualizado, páginas 25 e 26. Os mapas são auxiliares de revisão e foram acompanhados de leitura crítica.

COFEN. Resolução nº 736/2024 - Implementação do Processo de Enfermagem.
https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

COFEN. Resolução nº 754/2024 - Prontuário eletrônico e registros de enfermagem.
https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-754-de-16-de-maio-de-2024/

COFEN. Guia de Recomendações para Registros de Enfermagem no Prontuário.
https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-Vers%C3%A3o-Web.pdf

COFEN. Recomendações para registros de enfermagem.
https://www.cofen.gov.br/recomendacoes-para-registro-de-enfermagem-no-prontuario-do-paciente-e-outros-documentos-de-enfermagem/

BRASIL. Lei nº 7.498/1986 - Exercício profissional da Enfermagem.
https://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986/

BRASIL. Decreto nº 94.406/1987 - Regulamentação da Lei nº 7.498/1986.
https://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687/

Ministério da Saúde. Proteção de dados pessoais e LGPD.
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais

Aviso educativo

Esta apostila não substitui treinamento, protocolo institucional, supervisão do enfermeiro ou avaliação clínica. Em divergência, siga a norma vigente e o fluxo do serviço.